



EBOOK

GRATUITO

ABORDAGEM DA **HAS E DM2** NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Condutas práticas para o dia a dia
do médico na UBS



ROTINA CLÍNICA



ROTINA
CLÍNICA

Sobre este material

Este ebook foi elaborado pela equipe do **Rotina Clínica** para apoiar médicos e estudantes que atuam na Atenção Básica e UBS no manejo das duas condições crônicas mais prevalentes da prática ambulatorial: a **Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)** e o **Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)**.

O conteúdo abrange apresentação clínica, critérios diagnósticos, propedêutica, tratamento farmacológico disponível no SUS e critérios de referenciamento — com foco total na realidade do sistema público de saúde brasileiro.

Para mais conteúdos gratuitos, acesse **rotinaclinica.com**.

Sumário

Capítulo 1 — Abordagem da HAS na UBS/Atenção Primária

Capítulo 2 — Abordagem da DM2 na UBS/Atenção Primária

Capítulo 1 — Abordagem da HAS na UBS/Atenção Primária

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Forma habitual (maioria dos casos): assintomática.

→ Achado em aferição de rotina, consulta de outro motivo, ou rastreio anual.

Sintomas inespecíficos que podem ocorrer (não confirmam nem excluem HAS)

→ Cefaleia, tontura, zumbido, fadiga, epistaxe — geralmente não se correlacionam com o nível pressórico.

Sinais de alarme para lesão de órgão-alvo já instalada

→ Dor torácica, dispneia, palpitações, edema periférico, claudicação, alterações visuais, noctúria, hematúria, déficits neurológicos focais, alteração do estado mental.

Suspeita de HAS secundária (cinco a dez por cento dos casos) quando

→ Início antes dos 30 ou após os 50 anos, ou lesão de órgão-alvo desproporcional ao tempo de doença.

→ Hipertensão resistente/refratária (ver seção 5).

→ Tríade do feocromocitoma: palpitações + sudorese + cefaleia em crises.

→ Sinais de apneia obstrutiva do sono.

→ Biótipo/estigmas de Cushing, acromegalia, hipertireoidismo.

→ Sopros abdominais/em território arterial, massas abdominais, assimetria de pulsos (sugerem coarctação/doença renovascular).

→ Hipopotassemia espontânea ou induzida por diurético.

→ Alterações urinárias (hematúria dismórfica, proteinúria) ou queda de TFGe.

Crise hipertensiva (PA $\geq 180/110$ mmHg) — diferenciar já na triagem do PS

→ Pseudocrise: sintomas de estresse/dor/ansiedade com PA elevada reativa — não é crise verdadeira; reavaliar após repouso.

→ Urgência hipertensiva (UH): PA muito elevada sem lesão aguda de órgão-alvo, geralmente por má adesão/tratamento inadequado.

→ Emergência hipertensiva (EH): PA elevada com lesão aguda e progressiva de órgão-alvo — AVC, encefalopatia hipertensiva, SCA, edema agudo de pulmão, dissecção de aorta, insuficiência renal aguda, retinopatia aguda, pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia/HELLP.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

Classificação da PA em consultório (adultos)

Categoria	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Ótima	<120	<80
Normal	120–129	80–84
Normal-alta (pré-hipertensão)	130–139	85–89
HAS Grau 1	140–159	90–99
HAS Grau 2	160–179	100–109

Categoria	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
HAS Grau 3	≥180	≥110

Confirmação diagnóstica

- PA <130/85mmHg: repetir em 1 ano (reforçar MEV).
- PA 130/85–139/89mmHg (normal-alta): se fatores de risco CV → reaverir em mais 2 ocasiões, intervalo 7–14 dias; se sem fatores de risco → apenas orientar MEV.
- PA ≥140/90mmHg: requer confirmação em avaliações repetidas (2–3 medidas, intervalo de 1 dia a 4 semanas conforme gravidade):
- Grau 1 (140–159/90–99): confirmar com nova medição em 7–14 dias.
- PA ≥160/100: consulta médica imediata.
- PA ≥180/110 ou DCV/lesão de órgão-alvo já presente: diagnóstico pode ser fechado em uma única consulta.
- MAPA ou MRPA (quando disponível) confirma diagnóstico em caso de suspeita de hipertensão do avental branco (PA alta só no consultório) ou mascarada (PA normal no consultório, alta fora dele) — 10–30% e 10–15% dos casos, respectivamente.

Crianças/adolescentes

- <13 anos: normal se PA < percentil 90; HAS grau 1 se ≥P95 até P95+12mmHg; grau 2 se ≥P95+12mmHg.
- ≥13 anos: usar os mesmos cortes do adulto (140/90 = HAS).

Gestantes

- PAS ≥140 ou PAD ≥90mmHg (2 medidas, intervalo ≥4h; se PAS ≥160 ou PAD ≥110, repetir em 15min).
- Antes da 20ª semana: HAS crônica (pré-existente).
- Após a 20ª semana, sem proteinúria/disfunção de órgão-alvo: hipertensão gestacional.
- Após a 20ª semana, com proteinúria significativa ou disfunção de órgão-alvo (plaquetas <150.000, TGO/TGP >40, creatinina >1,2): pré-eclâmpsia.
- HELLP: hemólise (bilirrubina total >1,2) + TGO/TGP >70 + plaquetas <100.000 + DHL >600.

PROPEDÊUTICA — EXAMES NA CONSULTA INICIAL

Objetivo: detectar lesão de órgão-alvo, estratificar RCV e rastrear causa secundária.

Exames de rotina (todo paciente com HAS confirmada)

- Sódio, potássio, ácido úrico, creatinina + TFGe.
- Glicemia de jejum (ou HbA1c) e perfil lipídico completo.
- RAC (relação albumina/creatinina urinária) ou teste de urina tipo I.
- ECG de 12 derivações (FA, HVE, cardiopatia isquêmica).
- Cálculo de IMC e circunferência abdominal.

Estratificação do RCV

- Fazer em todo paciente com PA normal-alta ou HAS, sem DCV prévia.
- Calculadora HEARTS/OPAS/OMS, reavaliar anualmente entre 40–74 anos independente da PA.

Exames adicionais se suspeita de HAS secundária ou lesão de órgão-alvo

- Ecocardiograma (HVE, disfunção sistólica/diastólica).

- USG de carótidas (placas/estenose) e USG renal com Doppler (suspeita renovascular).
- Relação aldosterona-renina ou triagem para excesso de cortisol.
- TGO/TGP/GGT/FA (função hepática).
- Fundo de olho — obrigatório em HAS grau 3, diabetes associado, ou lesão de órgão-alvo.

Periodicidade de reavaliação

- Exames laboratoriais (perfil lipídico, glicemia/HbA1c, creatinina, K/Na, urinálise): anual, no mínimo a cada 2 anos.
- Consultas: mensal até atingir meta; após meta, 2–4x/ano no 1º ano (intervalo de 3–6 meses).

TRATAMENTO PRÁTICO (FOCO EM DISPONIBILIDADE SUS)

Metas de PA

População	Meta
Geral (<65 anos, bem tolerado)	<130/80mmHg
Geral (mínimo aceitável)	<140/90mmHg
Idosos frágeis	140–149/70–79mmHg (meta flexível)
DAC associada	<130/80mmHg (nunca <120/70 em assintomático; cautela se PAD muito baixa e isquemia)
Gestantes	PAD em torno de 85mmHg; PAS 120–160 / PAD 80–110

Medidas não farmacológicas (sempre, em todos os graus)

- Peso: IMC<25 (adulto) / <27 (idoso).
- Dieta DASH; sódio <2g/dia (sal <5g/dia); potássio ≥3,5g/dia (exceto DRC).
- Atividade física: 150min/semana moderada (meta ideal 300min/semana).
- Álcool: ≤2 doses/dia (homens), ≤1 dose/dia (mulheres).
- Cessação total de tabagismo (incluindo eletrônico e narguilé).
- Redução de estresse, meditação, sono de qualidade.

Fármacos Disponíveis no SUS (RENAME — Componente Básico)

Classe	Fármaco	Dose habitual/dia	Dose máx/dia	Frequência
IECA	Captopril	25–150mg	250mg	2–3x
IECA	Enalapril (maleato)	5–40mg	40mg	1–2x
BRA	Losartana potássica	50–100mg	100mg	1–2x
BCC di-hidropiridínico	Anlodipino (besilato)	2,5–10mg	10mg	1x
BCC di-hidropiridínico	Nifedipino	10mg	10–60mg	1–3x
BCC não di-hidropiridínico	Verapamil	120–360mg	480mg	1–2x
Diurético tiazídico	Hidroclorotiazida	25–50mg	200mg	1–2x
Diurético de alça	Furosemida	20–80mg	variável	1–3x
Diurético poupador de K	Espironolactona	25–100mg	200mg	1–2x

Classe	Fármaco	Dose habitual/dia	Dose máx/dia	Frequência
BB não cardiosseletivo	Propranolol	80–320mg	640mg	2–3x
BB cardiosseletivo	Atenolol	50–100mg	100mg	1–2x
BB cardiosseletivo/vasodilatador	Carvedilol	12,5–50mg	50mg	1–2x
BB cardiosseletivo	Metoprolol (succinato/tartarato)	50–200mg	200mg	1–2x
Simpatolítico central	Metildopa	500–2000mg	3g	2–3x
Alfabloqueador	Doxazosina (mesilato)	1–16mg	16mg	1x
Vasodilatador direto	Hidralazina	50–200mg	200mg	2–3x

→ Combinações fixas em comprimido único NÃO estão disponíveis no SUS — usar sempre comprimidos separados.

Algoritmo prático — sem comorbidades

- 1. HAS grau 1 + RCV baixo, ou idoso frágil → monoterapia (IECA/BRA, BCC ou diurético tiazídico).
- 2. Demais casos (grau 1 + RCV moderado/alto, ou graus 2–3) → iniciar direto com combinação dupla: (IECA ou BRA) + (BCC ou diurético tiazídico).
- 3. Sem meta em ~1 mês → combinação tripla: IECA/BRA + BCC + diurético tiazídico.
- 4. Sem meta → 4º fármaco: espironolactona (preferencial) — se efeitos adversos, trocar por eplerenona (não SUS) ou considerar alfabloqueador/BB/hidralazina.
- 5. Antes de qualquer escalonamento: reforçar adesão e reavaliar após pelo menos 1 mês de uso — falha terapêutica só se confirma com boa adesão.

Atenção: Nunca associar IECA + BRA (sem redução de desfechos, mais efeitos adversos — ONTARGET). Betabloqueador pode ser considerado em qualquer etapa se houver indicação específica (ver abaixo).

Populações e comorbidades específicas

Condição	Conduta prática
DAC	BB + BCC preferenciais se sintomático (angina) ou pós-IAM; iniciar dupla IECA/BRA + BB se tolerado
DRC (TFGe<60)	IECA/BRA + BCC/diurético; diurético de alça (furosemida) se TFGe<30 (tiazídico perde eficácia); cuidado com hipercalcemia se espironolactona + TFGe<45 ou K≥4,5
IC com FE reduzida	IECA/BRA + BB + espironolactona (tripla já de início); diurético de alça se congestão
Fibrilação atrial	BRA + BB (ou BCC não-di-hidropiridínico se sem IC); avaliar CHA ₂ DS ₂ -VA para anticoagulação
Gestante	Metildopa é 1ª linha (praticamente única indicação); hidralazina e HCTZ são alternativas SUS; contraindicados: IECA, BRA, espironolactona, atenolol
População preta	Diurético tiazídico como 1ª escolha (isolado ou + BCC); evitar IECA/BRA como monoterapia inicial
Idoso frágil (≥75a, ILPI, acamado, demência, etc.)	Monoterapia, meta flexível 140–149/70–79mmHg

Condição	Conduta prática
Betabloqueador — indicações específicas para priorizar	IC com FE reduzida, pós-IAM/angina, FA/controle de FC, mulher em idade fértil/planejando gravidez, DRC em hemodiálise

Efeitos adversos e contraindicações-chave (para prescrição segura na UBS)

- IECA: tosse (10%, mais em negros), angioedema, contraindicado em gestação e associação com BRA.
- BRA: melhor tolerância que IECA, sem tosse; evitar em gestação (2º/3º trimestre).
- Espironolactona: hipercalemia (cautela se TFG_e<45 ou K≥4,5); ginecomastia.
- BCC di-hidropiridínico: edema de MMII (não responde a diurético, melhora com IECA/BRA).
- Verapamil/Diltiazem: evitar com betabloqueador (bradicardia); contraindicados em ICfEr.
- Betabloqueador: evitar em broncopatia grave, bloqueio AV, bradicardia <50bpm, DAOP (exceto vasodilatadores); retirada sempre gradual (2–4 semanas).
- Hidroclorotiazida: evitar em insuficiência renal/hepática grave e distúrbio eletrolítico importante.
- Atenolol: contraindicado na gestação (restrição de crescimento fetal) e na amamentação.

CRISE HIPERTENSIVA NO PRONTO-SOCORRO

Passo 1 — Confirmar e classificar

- Reaverificar a PA corretamente antes de rotular como crise (excluir "pseudocrise" por dor/ansiedade/erro técnico).
- Urgência hipertensiva: PA≥180/110 sem lesão aguda de órgão-alvo.
- Emergência hipertensiva: PA elevada com lesão aguda de órgão-alvo (ver sinais na seção 1).

Passo 2 — Urgência hipertensiva

- Não reduzir PA de forma brusca.
- Identificar e corrigir fator desencadeante (má adesão, dor, uso de AINE/estimulante, suspensão abrupta de clonidina/BB).
- Anti-hipertensivo oral (ex.: captopril), redução gradual em 24–48h.
- Paciente sem risco iminente e assintomático → observação e alta, com reavaliação ambulatorial em até 7 dias.

Passo 3 — Emergência hipertensiva

- Tratamento IV, imediato, preferencialmente em UTI.
- Meta de redução: ≤25% da PA média na 1ª hora; PA≈160/100–110 em 2–6h; PA≈135/85 em 24–48h.

Metas específicas por órgão-alvo

Situação	Conduta/meta
AVC isquêmico	Reduzir só se PA muito elevada (≥185/110 com trombólise; ≥220/120 sem trombólise)
AVC hemorrágico	Manter PAS entre 140–180mmHg
Encefalopatia hipertensiva	↓PAS ≤25% na 1ª hora
Síndrome coronariana aguda	↓PA em 20% nas primeiras 2h
Edema agudo de pulmão/IC aguda	Diurético de alça + vasodilatador
Dissecção de aorta	↓PAS rapidamente para 100–120mmHg

Situação	Conduta/meta
Excesso simpático (feocromocitoma, cocaína)	Evitar BB isolado (risco de vasoconstrição paradoxal)
Gestação (pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia)	Nifedipino oral ou hidralazina IV + monitorização materno-fetal; sulfato de magnésio se PAS $\geq$ 160/PAD $\geq$ 110 (mesmo assintomática) ou risco de convulsão

→ Após controle inicial, transicionar para via oral conforme estabilidade.

→ Toda emergência hipertensiva: reavaliação ambulatorial obrigatória em até 7 dias.

Quando acionar SAMU/encaminhar à emergência a partir da UBS

→ PAS $\geq$ 180 e/ou PAD $\geq$ 120mmHg.

→ Qualquer sinal de lesão aguda de órgão-alvo (déficit neurológico, dor torácica, dispneia súbita, alteração do estado mental).

→ Necessidade de monitorização contínua.

QUANDO REFERENCIAR AO ESPECIALISTA

Suspeita de HAS secundária (encaminhar para investigação — cardiologia/endocrinologia/nefrologia conforme suspeita):

→ Início <30 ou >50 anos com lesão de órgão-alvo desproporcional.

→ Tríade de feocromocitoma, sinais de Cushing/acromegalia/tireoidopatia.

→ Hipopotassemia espontânea, sopros abdominais, assimetria de pulsos.

→ Suspeita de doença renal parenquimatosa ou renovascular (RAC alterada, queda de TFGe, USG suspeita).

Hipertensão resistente e refratária

→ HAR: PA $\geq$ 140/90 apesar de 3 classes (bloqueador do SRAA + BCC + diurético tiazídico) em doses máximas toleradas, por $\geq$ 6 meses, com boa adesão confirmada.

→ HAR controlada: PA controlada, mas com $\geq$ 4 fármacos.

→ Refratária: PA não controlada mesmo com $\geq$ 5 classes.

→ Antes de encaminhar: sempre excluir má adesão e otimizar doses/combinação na UBS.

Falha de tratamento em crianças/adolescentes

→ Sem resposta à monoterapia por >6 meses.

Gestação

→ HAS grave ($\geq$ 160/110), pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELLP → emergência obstétrica, encaminhar imediatamente.

Situações que exigem avaliação especializada além da PA

→ Lesão de órgão-alvo significativa (HVE importante, retinopatia avançada, DRC com TFGe<30 ou RAC $\geq$ 300).

→ Emergência hipertensiva com necessidade de UTI.

→ Dúvida diagnóstica entre hipertensão do avental branco/mascarada sem acesso a MAPA/MRPA na atenção básica.

PONTOS-CHAVE PARA FIXAR

- 1. PA $\geq$ 140/90 requer confirmação (exceto se $\geq$ 180/110 ou já houver DCV/lesão de órgão-alvo, que fecha em 1 consulta).
 - 2. Meta geral <130/80 se bem tolerada; idosos frágeis: 140–149/70–79.
 - 3. A maioria dos pacientes começa com terapia DUPLA: (IECA ou BRA) + (BCC ou tiazídico) — monoterapia só em grau 1/RCV baixo ou idoso frágil.
 - 4. Nunca associar IECA + BRA.
 - 5. 4º fármaco = espironolactona (cautela se TFG $<$ 45 ou K $\geq$ 4,5).
 - 6. Gestante: metildopa é 1ª linha; IECA/BRA/espironolactona/atenolol são contraindicados.
 - 7. Emergência hipertensiva: reduzir no máximo 25% da PA média na 1ª hora — nunca normalizar rápido, exceto dissecção de aorta.
 - 8. Sempre revisar adesão antes de rotular como hipertensão resistente.
-

REFERÊNCIAS

- Diretriz Brasileira de HAS 2025 (Brandão et al., Arq Bras Cardiol).
- PCDT HAS (Portaria SECTICS/MS nº 49/2025).

Capítulo 2 — Abordagem da DM2 na UBS/Atenção Primária

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Assintomático (mais comum)

→ Achado em rastreio de rotina (glicemia de jejum, pré-natal, check-up) em paciente com fatores de risco.

Sintomático clássico

- Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso não intencional.
- Turvação visual, fadiga, infecções de repetição (candidíase genital, ITU).
- Lentidão na cicatrização de feridas.

Sinais de alarme — suspeitar de insulinopenia

- Perda de peso rápida, desidratação, hálito cetônico, dor abdominal, taquipneia.
- Avaliar cetoacidose diabética (DM1/LADA; pode ocorrer em DM2 descompensado).

Fatores de risco

- Sobrepeso/obesidade central, sedentarismo, história familiar de DM, HAS, dislipidemia.
- SOP, DM gestacional prévio, macrosomia fetal, etnia de risco, idade ≥ 35 anos.
- Uso de corticoide ou antipsicótico.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

→ Critérios diagnósticos segundo a American Diabetes Association (ADA) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Confirma-se DM2 com 2 critérios positivos ou 1 confirmado em segunda amostra (exceto sintomas clássicos + glicemia franca).

Critério diagnóstico	Valor
Glicemia de jejum ($\geq 8h$)	≥ 126 mg/dL
Glicemia 2h após TOTG (75g)	≥ 200 mg/dL
HbA1c	$\geq 6,5\%$
Glicemia aleatória + sintomas	≥ 200 mg/dL (não precisa repetir)

Pré-diabetes — rastrear anualmente e intervir

→ Glicemia jejum 100–125 mg/dL, TOTG 2h 140–199 mg/dL, ou HbA1c 5,7–6,4%.

Rastreio na UBS

- Todo adulto ≥ 35 anos, a cada 3 anos.
- Anual: IMC ≥ 25 + 1 fator de risco (HAS, dislipidemia, HF de DM, DM gestacional, SOP, sedentarismo, DCV).

PROPEDÊUTICA INICIAL

Confirmação e classificação de risco

- Glicemia de jejum e/ou HbA1c.
- Suspeita de DM1/LADA: <35 anos, magro, sem SM, perda de peso → anti-GAD antes de iSGLT2.

Avaliação cardiorrenal (obrigatória no diagnóstico novo)

- TFGe (creatinina + fórmula CKD-EPI).
- RAC — relação albumina/creatinina em amostra de urina isolada (fita ou EAS não substitui).
- Perfil lipídico completo e PA em consultório.

Rastreio de complicações

- IMC e circunferência abdominal.
- ECG se ≥35 anos ou fator de risco CV adicional.
- Fundo de olho (retinopatia) — encaminhar ao oftalmo no diagnóstico.
- Exame dos pés (monofilamento, pulsos, inspeção) — rastreio de neuropatia e DAOP.
- TSH (maior prevalência de tireoidopatia associada).

Periodicidade de reavaliação

- HbA1c: 3/3 meses se fora da meta; 6/6 meses se controlado.
- TFGe + RAC: anual (ou mais frequente se Doença Renal do DM já estabelecida).
- Perfil lipídico e exame dos pés: anual.
- Fundo de olho: anual; a cada 2 anos se sem retinopatia e bom controle.

Tratamento

Fármacos no SUS — Atenção Básica (sem LME)

- Metformina (comprimido simples e XR em algumas regiões).
- Gliclazida.
- Insulina NPH e Regular.

Exige CEAF/Alto Custo ou Farmácia Popular

Dapagliflozina

- Critério: DM2 + doença CV estabelecida (IAM, RVM, angioplastia, angina, AVC/AIT prévio, IC com FE<40%) OU ≥55 anos (homem)/≥60 anos (mulher) com alto risco CV, já em uso otimizado de metformina + sulfonilureia sem controle adequado.
- Desde 2025: gratuita pela Farmácia Popular para DM2 + DCV/renal ou idade ≥65 anos.
- iDPP-4, AR GLP-1 (liraglutida, semaglutida, dulaglutida), tirzepatida e insulinas análogas (glargina, degludeca, asparte, lispro) ainda não integram a lista padrão do SUS — disponíveis apenas via compra particular, plano de saúde ou judicialização.
- Verificar sempre protocolo estadual/municipal, pois pode haver variação local.

PASSO A PASSO PRÁTICO NA UBS

Passo 1 — Início (TFG≥30, assintomático)

Metformina

- 500mg 1x/dia com refeição.

- Titular a cada 1–2 semanas conforme tolerância GI até 850–1000mg 2x/dia (dose-alvo eficaz; máx 2550mg/dia).
- Reforçar mudança de estilo de vida: dieta, atividade física ≥ 150 min/semana, cessação de tabagismo.
- Solicitar TFGe/RAC e perfil lipídico se ainda não feito.

Passo 2 — Sem meta em 3 meses ou HbA1c $\geq 7,5$ ao diagnóstico

- HbA1c $\geq 7,5\%$ ao diagnóstico, ou sem meta em 3 meses de metformina isolada.

Associar 2º fármaco disponível no SUS

- Se RCR aumentado (DCV estabelecida, $\geq 55/60$ anos + fator de risco, DRD) e critérios CEAF preenchidos
- tentar via LME dapagliflozina 10mg 1x/dia.
- Se sem acesso a dapagliflozina ou sem critério CEAF → Gliclazida 30–60mg 1x/dia (dose máx 120mg/dia)
- preferir a glibenclamida pelo menor risco de hipoglicemia.

Gliclazida

- 30–60mg 1x/dia; dose máxima 120mg/dia.
- Alternativa: Gliclazida XR 1x/dia, 30 a 120 mg (máx 120mg/dia) — cautela se TFGe < 30 (maior risco de hipoglicemia prolongada).

Passo 3 — Sem meta em 3 meses de terapia dupla

- Terapia tripla: metformina + glibenclamida + dapagliflozina (se critério CEAF) ou iniciar insulinização.

Passo 4 — Insulinização

- Indicação: sintomas de insulinopenia, hiperglicemia grave > 300 mg/dL, HbA1c $> 10\%$, falha de tripla terapia.

Insulina NPH

- Aplicar ao deitar; dose inicial 0,1–0,2 UI/kg/dia (ex.: 10UI).
- Titular 2UI a cada 3 dias conforme glicemia de jejum (alvo 80–130mg/dL).

Obs: Manter metformina; suspender sulfonilureia ao iniciar esquema basal-bolus — risco de hipoglicemia.

Se necessário insulina prandial

Insulina Regular

- Aplicar 30min antes das refeições; iniciar 4UI ou 10% da dose basal por refeição.
- Titular conforme glicemia pós-prandial.

Ajuste renal — fármacos disponíveis no SUS

Fármaco	Ajuste (TFGe 30–59 / TFGe < 30)
Metformina	30–59: $\downarrow 50\%$ máx 1g/dia (TFG 30–45); < 30 : suspender
Glibenclamida	Contraindicada se TFG < 60 / Contraindicada
Gliclazida	Sem ajuste, cautela / Cautela, dose reduzida
Dapagliflozina	Iniciar/manter (não iniciar se TFG < 25) / Não iniciar; manter se já em uso
Insulina NPH/Regular	Sem ajuste / Titular — maior risco de hipoglicemia, reduzir dose gradualmente

HIPERGLICEMIA GRAVE NA UBS

- Glicemia capilar muito elevada ($>300\text{--}400\text{mg/dL}$) sem sinais de descompensação aguda (cetose, desidratação grave, rebaixamento) → iniciar insulina NPH e reavaliar em 48–72h.
- Sinais de cetoacidose/estado hiperosmolar → encaminhar para emergência, não manejar na UBS.

QUANDO REFERENCIAR AO ENDOCRINOLOGISTA

Suspeita de etiologia diferente de DM2 clássico

- Idade <35 anos, magro (IMC normal), sem síndrome metabólica → investigar LADA/DM1 (anti-GAD) ou MODY (história familiar de DM em 3 gerações, sem obesidade).
- Perda de peso importante + sintomas insulínopênicos em jovem magro.
- DM associado a outras endocrinopatias (Cushing, acromegalia, hipertireoidismo) — sinais clínicos sugestivos.
- Diabetes secundário a doença pancreática (pancreatite crônica, fibrose cística, pós-pancreatectomia).
- Suspeita de diabetes monogênico (neonatal ou diagnosticado <6 meses de vida).

Dificuldade de controle/complexidade terapêutica

- HbA1c persistentemente fora da meta apesar de terapia tripla otimizada na UBS.
- Necessidade de terapias não disponíveis no SUS (AR GLP-1, tirzepatida, insulinas análogas) em paciente com $\text{IMC} \geq 30$, RCR muito alto ou múltiplas hipoglicemias.
- Hipoglicemias recorrentes ou graves de difícil controle.
- Necessidade de insulinização complexa (esquema basal-bolus, bomba de infusão).

Complicações estabelecidas que exigem manejo especializado

- Doença renal do diabetes com $\text{TFGe} < 30$ ou $\text{RAC} \geq 300$ refratária (encaminhar também à nefrologia).
- Retinopatia proliferativa ou edema macular (encaminhar oftalmo com urgência).
- Pé diabético com úlcera, infecção ou isquemia (encaminhar a serviço de referência/cirurgia vascular).
- Neuropatia autonômica cardiovascular grave ou gastroparesia.

Situações especiais

- Gestação com DM2 prévio ou DM gestacional de difícil controle.
- Criança/adolescente com diagnóstico de diabetes.
- Pré-operatório de cirurgia bariátrica em paciente com DM2.

PONTOS-CHAVE PARA FIXAR

- Rastreio: todo adulto ≥ 35 anos a cada 3 anos; antes disso se sobrepeso + 1 fator de risco.
- Diagnóstico: jejum ≥ 126 , $\text{HbA1c} \geq 6,5\%$, $\text{TOTG2h} \geq 200$, ou aleatória ≥ 200 + sintomas.
- 1ª linha sempre metformina (se $\text{TFG} \geq 30$), titulando até dose eficaz antes de trocar.
- Na UBS, o 2º fármaco de escolha é gliclazida ou glibenclamida; dapagliflozina exige critério CEAF (DCV estabelecida ou alto risco CV + falha de metformina+SU).
- Glibenclamida contraindicada se $\text{TFG} < 60$ — preferir gliclazida.
- Insulina NPH ao deitar é a insulinização padrão disponível no SUS.
- Referenciar sempre que houver suspeita de etiologia não-DM2 clássica (jovem magro) ou falha terapêutica com os recursos da UBS.

Referência: Manejo do Diabetes Mellitus Tipo 2 - SBD.

Gostou do conteúdo?

Acesse nossa plataforma completa com condutas clínicas, prescrições práticas, calculadoras e cursos para médicos e estudantes.

www.rotinaclinica.com

@rotina.clinica • www.rotinaclinica.com

Gostou do conteúdo?

Acesse nossa plataforma completa com condutas clínicas, prescrições práticas, calculadoras e cursos para médicos.

Quero assinar o Rotina Clínica →